Normandie Université

UFR Santé

UNIVERSITÉ DE ROUEN NORMANDIE

DÉPARTEMENT DE MÉDECINE GÉNÉRALE

CONTRÔLE GLYCÉMIQUE ET RISQUE INFECTIEUX BACTÉRIEN CHEZ LE PATIENT DIABÉTIQUE DE TYPE 2 : ANALYSE D'UNE BASE DE DONNÉES DE MÉDECINE GÉNÉRALE

E. LEMOINE[1], M. DUSENNE[2], M. SCHUERS[1,2]

1 : DMG Rouen, UNIROUEN, Département de Médecine Générale, F-76000 Rouen, France, 2 : Département d'Informatique et d'Information Médicales, CHU de Rouen, F-76000, France
CONTACT : edouard.lemoine1@univ-rouen.fr
Conception : B. Soudais[1]

CONTEXTE

En 2020, 3,5 millions de patients souffraient de diabète en France. Il existe chez le patient diabétique de type 2 (DT2) une augmentation du risque infectieux dont le mécanisme physiopathologique demeure imprécis. L'impact du contrôle glycémique sur ce risque infectieux ne fait pas consensus et les résultats des études semblent hétérogènes.

OBJECTIFS

PRINCIPAL : mesurer l'association entre le contrôle glycémique et le risque infectieux bactérien
SECONDAIRE : mesurer l'association entre la sévérité du diabète (nombre et type de traitements DT2) et le risque infectieux bactérien

LE RISQUE INFECTIEUX BACTÉRIEN N'EST PAS ASSOCIÉ AU CONTRÔLE GLYCÉMIQUE CHEZ LES PATIENTS DIABÉTIQUES DE TYPE 2

MÉTHODOLOGIE

ENTREPÔT DE DONNÉES : PRIMEGE NORMANDIE

Janvier 2012 – décembre 2022
40 MG, 3 442 420 consultations
103 649 patients dont 84 012 adultes
4,7 consultations/an/patient en moyenne

ALGORITHME DE DÉTECTION DES PATIENTS DIABÉTIQUES

Tout patient DT2 détecté selon l'algorithme suivant :
Codage "diabete de type 2" (CISP)
dans les antécédents et/ou les consultations
OU prescriptions de traitements antidiabétiques
+ Âge > 18 ans
+ Nombre de dosages HbA1c > 3
+ Nombre de consultations > 3

DÉFINITIONS DES CRITÈRES DE JUGEMENT

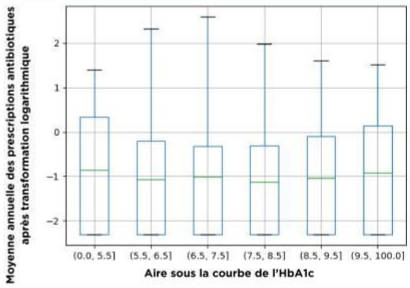
CONTRÔLE GLYCÉMIQUE
Aire sous la courbe de l'hémoglobine glyquée (HbA1c-AUC)

SÉVÉRITÉ DIABÈTE
Nombre et type de traitement antidiabétique (ATC A10B)

RISQUE INFECTIEUX
Moyenne annuelle des prescriptions antibiotiques (ATB) (ATC J01)

RÉSULTATS

AUCUNE ASSOCIATION
HbA1c-AUC et prescriptions ATB ($p = 0,228$)
Type de traitement DT2 et prescriptions ATB ($p = 0,018$)
Nombre de traitement DT2 et prescriptions ATB ($p = 0,530$)



HbA1c-AUC	EFFECTIFS	ANTIBIOTIQUES	
< 5,5 %	27 (1,38 %)	0,88	
5,5 - 6,5 %	473 (24,14 %)	0,62	ANOVA
6,5 - 7,5 %	817 (41,70 %)	0,54	$p = 0,228$
7,5 – 8,5 %	422 (21,54 %)	0,50	
8,5 – 9,5 %	158 (8,07 %)	0,57	
> 9,5 %	62 (3,10 %)	0,63	

Patients DT2 (n) : 1959 (1,89 %)
Année de naissance : 1951 (± 12,54)
Sexe ratio H/F : 1,24 (1077 / 870)
IMC moyen : 30,39 kg/m²
Durée de suivi moyen : 5,3 ans

Aucun traitement : 182 (9,29 %)
ADO seuls : 1041 (53,14 %)
Non insuliniques injectables : 233 (11,89 %)
Insuliniques : 503 (25,68 %)

Société Francophone du Diabète congrès annuel
Montpellier • 2023
Du 21 au 24 mars
Parc des expositions

DISCUSSION

Il n'a pas été retrouvé d'association entre contrôle glycémique chronique, sévérité du diabète et risque infectieux bactérien chez les patients DT2. Des études suggèrent un impact plus important de l'hyperglycémie aiguë. C'est la première étude française évaluant le risque infectieux chez les patients DT2 à partir d'une base de données de médecine générale. L'exploitation de ces données témoigne le fort potentiel de recherche pour les soins primaires.

FORCES & FAIBLESSES

- Nombreux patients, données de soins primaires, étude du contrôle glycémique chronique
- Pas de données hospitalières, approximation des données par méthode de détection indirecte, limitation aux infections bactériennes